

SALUD BUCAL DE LOS NIÑOS

Bibliográfica 2025 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David

La enfermedad bucal más prevalente en niños es la caries dental.

Enfermedad infecciosa, crónica y de etiología multifactorial. Se transmite de un individuo portador a otro susceptible principalmente por vía salival. El agente bacteriano más relevante en su inicio es *Streptococcus mutans*, cuya colonización temprana se asocia con mayor riesgo de caries en la infancia. La transmisión ocurre habitualmente al compartir utensilios contaminados o a través de besos en la boca, prácticas que facilitan la inoculación bacteriana en el lactante.

El período crítico de colonización es entre los 19 a los 31 meses (media de 26 meses).

La edad en la que el niño es colonizado por *Streptococcus mutans* es un factor determinante para su riesgo de caries.

La **caries de edad temprana** se manifiesta antes de los tres años. Inicia con una apariencia desmineralizada blanca en los dientes anteriores evolucionando rápidamente con patrones atípicos hacia la cavitación y destrucción total.

Hay una fuerte correlación entre la caries de “edad temprana” y el desarrollo posterior de caries en dentición primaria y permanente.

La caries dental puede ser detenida en los estadios iniciales cuando aún no ha cavitado, muchas veces con autocuidado y suficiente información por parte de los padres.

La calcificación de las estructuras dentarias comienza en la vida intrauterina para los dientes primarios y al nacer para los dientes permanentes. Toda situación que comprometa el embarazo o al niño en los primeros años determinará alteraciones en el esmalte dentario haciéndolo más proclive al ataque ácido y por lo tanto a la progresión de caries, por ej: cuadros respiratorios, episodios febriles, enfermedades virales, cardiopatías congénitas, prematurez, etc.

La **derivación del niño al odontopediatra** es con la erupción del primer diente que ofrece una superficie no descamativa, necesaria para la colonización de los *streptococos Mutans*.

Será el momento oportuno para el diagnóstico precoz de los factores de riesgo y para pautar medidas preventivas con los padres como evitar consumo de golosinas y bebidas azucaradas e incentivar el consumo de frutas y el cepillado regular de los dientes desde el inicio.

También se valora la aplicación tópica de fluoruros para interferir en el proceso de desmineralización y remineralización del esmalte y dentina, su efecto es mayor en el período post – eruptivo. Se sugiere aplicarlos en niños con alto riesgo de caries y sin patologías de base, previo estudio de las fuentes de provisión incluida el tenor en el agua de consumo. **No se recomienda su uso en embarazadas.**

Erupción dental

Habitualmente la erupción del diente primario produce una escasa sintomatología, ligero enrojecimiento e inflamación de la encía que será sustituido por una pequeña isquemia. En algunas ocasiones, este proceso va acompañado de un “quiste de erupción” que es una formación blanda, bien demarcada de color azulado o rojo oscuro, directamente en el área del diente y que generalmente no requiere tratamiento. La erupción dental puede producir molestias pero no cuadro febril.

Es más importante, para la armonía oclusal tener en cuenta la secuencia de erupción de los dientes.

Cronología y secuencia de erupción de los dientes primarios:

- **6 a 10 m:** Incisivo central inferior.
- **8 a 12 m:** Incisivo central superior.
- **9 a 13 m:** Incisivo lateral superior.
- **10 a 16 m:** Incisivo lateral inferior.
- **14 a 18 m:** Primer molar inferior.
- **13 a 19 m:** Primer molar superior.
- **15 a 21 m:** Canino inferior.
- **16 a 22 m:** Canino superior.
- **23 a 31 m:** Segundo molar inferior.
- **25 a 33 m:** Segundo molar superior.

Cronología y secuencia de erupción de los dientes permanentes:

El primer diente permanente en erupcionar es el Primer Molar. Aparece en boca antes del recambio de los dientes anteriores y pasa inadvertido por los padres, poniendo en riesgo de caries esas superficies muy vulnerables. Esto sucede a los 6 años de edad.

- **6 años:** 1er molar permanente.
- **6 1/2 / 7 años:** incisivos centrales inferiores.
- **7 años:** incisivos centrales superiores.
- **8 años:** incisivos laterales inferiores y superiores.
- **9 / 10 años:** caninos inferiores.
- **11 / 12 años:** caninos superiores.
- **10 / 12 años:** premolares superiores e inferiores.
- **11 / 13 años:** segundo molar inferior.
- **12 / 13 años:** segundo molar superior.

Traumatismos dentarios

Los traumatismos dentarios son frecuentes en niños, afectan ambas denticiones y generalmente involucran más de una pieza y los tejidos de sostén.

Del correcto tratamiento de la urgencia dependerá el pronóstico de la o las piezas dentarias afectadas.

En la dentición primaria:

El objetivo del tratamiento del diente primario traumatizado es mantener la integridad del germen del permanente sucesor, íntimamente relacionados, evitando cualquier maniobra que pudiese dañarlo.

- **Luxaciones extrusivas:**

Desplazamiento parcial hacia afuera de su alveolo.

La reubicación se hace con presión digital suave e inmediata derivación al odontólogo.

- **Luxaciones intrusivas:**

Desplazamiento del diente hacia el interior del alveolo, por impacto axial, quedando incrustado en el hueso alveolar.

Muchas veces el diente puede desaparecer totalmente de la boca por desplazamiento severo dentro del hueso alveolar y asumirse por error que está perdido. Se corroborará radiográficamente que no haya invadido el área del germen permanente y puede esperarse, en tal caso, una reerupción espontánea según criterio y seguimiento del especialista.

- **Luxaciones laterales:**

Desplazamiento del diente en dirección lateral (vestibular, lingual o palatina) respecto a su posición original, acompañado de fractura o compresión de la pared alveolar.

También es muy importante diagnosticar el compromiso del germen y la reubicación necesitará de una maniobra previa de “destrabe” de la raíz en la tabla ósea, que suele estar fracturada.

- **Avulsiones:**

El diente es expulsado de su alvéolo

La reimplantación está contraindicada en dientes primarios porque la necrosis pulpar es una complicación frecuente y pone en riesgo la normal evolución del permanente.

En la dentición permanente

- **Fracturas**

Es importante rescatar el fragmento expulsado y mantenerlo en medio húmedo para que no se deshidrate, en solución fisiológica o leche.

- **Avulsiones:**

La reimplantación es un tratamiento de elección, si bien no es posible garantizar su permanencia a largo plazo (alrededor de 5 años). El factor más crítico en el pronóstico es el tiempo de permanencia de la pieza fuera de la boca, el ideal es hacerla en forma inmediata:

- Tomar el diente por la corona.
- Evitar tocar la raíz.
- Enjuagarlo sin refregar con solución fisiológica si estuviera sucio.
- Reinsertar el diente en su lugar lo más rápido posible.

De no ser posible colocar el diente en leche, solución fisiológica o la saliva del niño (estos elementos no agreden el ligamento periodontal presente en la raíz) y concurrir inmediatamente a la consulta.

Infecciones odontógenas

Consenso AEP 2010, SAP

Clasificación y tratamiento

1. Gingivitis marginal

Tratamiento: lavado con clorhexidina tópica

2. Gingivitis ulcerativa – Periodontitis crónica – Pulpitis aguda

Tratamiento: se agrega Amoxicilina/clavulánico o Amoxicilina/Metronidazol por 10 días.

3. Flemón odontógeno

Tratamiento: Amoxicilina/Clavulánico, Ibuprofeno reglado, buches antisépticos.

4. Absceso dentario

Tratamiento: drenaje, Amoxicilina/Clavulánico, Ibuprofeno reglado, buches antisépticos.

5. Celulitis facial difusa

- Borramiento del surco vestibular, faciales y región en zona afectada.
- Dolor moderado a la palpación o no presente.
- No hay supuración, cuando aparece es tardía.
- Piel depresible, caliente, con presencia de eritema.
- Manifestaciones generales: fiebre, malestar.
- Linfadenopatía cervical (en este caso se denomina **Adenoflemón odontógeno**)

6. Celulitis facial circumscripta

- Dolor manifiesto o sin este
- Borramiento de surcos
- Tumoración difusa, firme, indurada, tensa, brillante, eritematosa, muy dolorosa a la presión digital.
- Manifestaciones generales: fiebre, malestar.
- Linfadenopatía cervical.

Tratamiento

- Amoxicilina/clavulánico a 50mg/Kg/día (alternativa: Clindamicina 40mg/Kg/día).
- Ibuprofeno reglado.
- Calor local.
- En guardia se puede indicar una dosis de Dexametasona IM.
- IC ambulatoria con Odontopediatría.

Criterios de internación

- Falta de tratamiento ATB inicial en 48 – 72 hs
- Afectación del estado general
- Intolerancia a líquidos o a la medicación oral
- Trismo importante

Tratamiento en internación

- Opciones ATB
 1. Ampicilina – Sulbactán (150mg/Kg/día c/6hs)
 2. Clindamicina a 40 mg/Kg/día
- Dexametasona 0.6 mg/Kg/día cada 8hs
- AINE reglado cada 8hs (en general dipirona)

- Ranitidina cada 12 hs
- Calor local
- Dieta blanda y fresca
- IC a Odontopediatría

7. Celulitis facial odontógena supurada

En general es posterior a celulitis facial con tratamiento ATB inadecuado

- Dolor lacerante en ocasiones
- Borramiento de los surcos
- Encías eritematosa y edematosas
- Pus con zona fluctante en la piel o mucosas
- Trismo intenso
- Malestar general con fiebre, astenia y anorexia

8. Celulitis facial odontógena diseminada (mediastinitis necrotizante descendente)

- La inflamación de los tejidos blandos se extiende a través de planos y fascias donde puede comprometer mediastino y causar la muerte secundaria a mediastinitis
- No respeta barreras anatómicas
- Paciente en mal estado general, septicémica

Tratamiento:

- En UTI
- Cirugía para drenar colecciones
- ATB de amplio espectro